

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文 献监测

近 7 天官方 PubMed 窗口：2026-06-02 至 2026-06-08。每篇文章单独成页，按 “标题、结论、主要内容、关键信息、启示” 快速浏览；启示严格区分已验证证据、作者观点和我的推断。

EDAT 新入库	PDAT 发表日期	MDAT 记录更新	精选入页
38	23	201	5

固定公网主页：<https://zhengyipharmacy-collab.github.io/pubmed-lymphoma-slides/>

- 下载 PDF
- 下载 PPTX

检索与筛选说明

PubMed 官方 ESearch/EFetch 于 2026-06-08 重新检索；窗口为 2026-06-02 至 2026-06-08，合并 EDAT、PDAT、MDAT 覆盖近 7 天新增、发表和记录更新。本日按当前规则纳入 5 篇，并排除 pubmed-history.json 中既往日期已覆盖 PMID；若条目为 MDAT 更新而非本周新发表，已在文章页状态中明确标注。

检索式：((DLBCL[Title/Abstract] OR "diffuse large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR "large B-cell lymphoma"[Title/Abstract] OR LBCL[Title/Abstract] OR PCNSL[Title/Abstract] OR "primary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "primary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR CNSL[Title/Abstract] OR "central nervous system lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary CNS lymphoma"[Title/Abstract] OR "secondary central nervous system lymphoma"[Title/Abstract]) AND lymphoma[Title/Abstract])

覆盖方向：BTKi、双抗、CAR-T/细胞治疗、ADC、免疫治疗、靶向联合、病例/病例系列、基础/机制/转化、耐药、CNS 穿透/药代、安全性和真实世界。

#	方向	疾病	PMID	标题	打开链接
1	真实世界 / 一线治疗强度	新诊断 DLBCL	42251703	治疗强度、疾病负担与新诊断 DLBCL 生存：城市学术中心真实世界研究	打开文献
2	机制与转化 / 蛋白基因组分型	DLBCL	42242231	DLBCL proteogenotype: 478 例肿瘤的蛋白组、转录组与基因组整合	打开文献
3	CAR-T / 采集前生物标志物	R/R LBCL / DLBCL	41596518	采集产物中的 CD8+CCR7+CD45RA- T 细胞：axi-cel CAR-T 扩增和结局预测标志物	打开文献
4	双抗 / T-cell engager 耐药机制	R/R B-NHL / LBCL	41569641	glofitamab 应答与耐药的分子特征：naïve-like T 细胞状态和 4-1BB 共刺激	打开文献
5	BTKi / PCNSL 安全性病例系列	PCNSL	41621897	PCNSL 中 tirabrutinib 相关皮肤不良事件：发生率、起病时间与处理	打开文献

治疗强度、疾病负担与新诊断 DLBCL 生存：城市学术中心真实世界研究

PMID 42251703

打开 PubMed 文献

Treatment intensity, illness burden, and disparities in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma treated at an urban academic center.

真实世界 / 一线治疗强度

新诊断 DLBCL

EDAT/PDAT/MDAT 命中：2026-06-07 新发表/新入库

P 城市学术中心新诊断 DLBCL 患者

I 较低或较高蒽环/环磷酰胺相对剂量强度的一线治疗实践

C ARDI <0.9 vs 较高 ARDI，并按 PS、CCI、DEL 等因素调整

O PFS、OS、疾病进展、非复发死亡、治疗耐受性

结论

344 例新诊断 DLBCL 回顾性研究显示，较低环磷酰胺/多柔比星平均相对剂量强度（ARDI <0.9）与更差 PFS、OS、疾病进展和非复发死亡相关；但低剂量强度也与基础疾病负担、治疗不耐受和高危特征交织，不能简单解释为单纯“给药不足”。

主要内容

- 研究来自城市学术癌症中心，评估治疗强度、疾病负担和社会经济因素对 DLBCL 生存的影响。
- 55% 患者接受较低强度治疗，定义为环磷酰胺和多柔比星 ARDI <0.9。
- ARDI、体能状态、Charlson 合并症指数和 double expressor lymphoma 均与 PFS/OS 相关。
- 低 ARDI 与更差 PFS（HR 2.59）、OS（HR 4.26）、疾病进展（sHR 1.86）和非复发死亡（sHR 5.45）相关。

关键信息

- 作者：Hua-Jay J Cherng、David DeStephano、Patrick Gould、David Sabatino、Alexander D Sanjurjo、Brian Cuzzo 等。
- 研究类型：单中心回顾性真实世界研究；不是随机剂量强度干预试验。
- 关键边界：低 ARDI 可能反映基线脆弱性、治疗不耐受和高危疾病，而不只是治疗不足。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认样本量、低 ARDI 定义、PFS/OS HR、进展风险、非复发死亡风险和多学科综合照护结论。

论文作者观点

论文作者观点：需要综合多学科照护来降低 DLBCL 治疗不足相关风险。

我的推断

我的推断：一线 DLBCL 真实世界登记应固定记录 ARDI、PS、合并症、DEL、毒性停减量和非复发死亡，避免只用“是否足量化疗”解释结局。

DLBCL proteogenotype：478 例肿瘤的蛋白组、转录组与基因组整合

Pathogenesis of diffuse large B cell lymphoma proteogenotypes.

机制与转化 / 蛋白基因组分型 DLBCL EDAT/PDAT/MDAT 命中；2026-06-04 新发表/新入库

PMID 42242231

打开 PubMed 文献

P 478 例 DLBCL 肿瘤及其多组学数据

I 蛋白组、转录组、基因组、单细胞和空间转录组整合分型

C 7 个 proteogenotype 之间，以及 PG4 与既有 COO/IPI/遗传分型的比较

O 高危分型、结局关联、MYC/TCF3/4 活性、BTG1 突变、CD8 T 细胞耗竭微环境

结论

Cancer Cell 研究整合 478 例 DLBCL 肿瘤的蛋白组、转录组和基因组，提出 7 类 proteogenotype；其中 PG4 独立于 COO、IPI 和遗传特征提示较差结局，并伴 MYC/TCF3/4 活性增强及 CD8 T 细胞耗竭微环境。

主要内容

- 研究用蛋白组整合基因组/转录组，解释 DLBCL 现有分型之外的高危异质性。
- 整合 478 例 DLBCL 肿瘤数据，识别 7 个 proteogenotype，跨越既有分子亚型。
- PG4 与较差结局相关，且独立于 cell-of-origin、IPI 和遗传特征；包含 ABC、GCB 和遗传未分类病例。
- 单细胞测序和空间转录组显示 PG4 中 MYC 与 TCF3/4 转录活性增强，微环境表现为耗竭 CD8+ T 细胞。

关键信息

- 作者：Julius C Enssle、Björn Häupl、Arber Qoku、Boya Wang、George W Wright、Sharon Barrans 等。
- 关键信息：PG4 共享 dark-zone-related B cell phenotype，并富集可激活 MYC 的 BTG1 突变。
- 研究定位：高影响力转化研究，不是临床治疗试验；启示在于诊断分层和靶点假设。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 478 例、7 个 proteogenotype、PG4 独立高危、BTG1/MYC、单细胞/空间组学和 CD8 T 细胞耗竭微环境。

论文作者观点

论文作者观点：该研究为未来 DLBCL 诊断和治疗策略提供 proteogenomic 框架。

我的推断

我的推断：后续 DLBCL 方案设计可考虑把 proteogenotype、MYC 活性、TME 耗竭状态与 Pola-R-CHP、CAR-T、双抗等结局做交叉分析，但目前不能把 PG4 直接作为临床选药依据。

采集产物中的 CD8+CCR7+CD45RA- T 细胞：axi-cel CAR-T 扩增和结局预测标志物

PMID 41596518

打开 PubMed 文献

Apheresis CD8+CCR7+CD45RA- T-Cells as a Novel Biomarker Associated with CAR T-Cell Kinetics and Clinical Outcome.

CAR-T / 采集前生物标志物 R/R LBCL / DLBCL MDAT 命中：近 7 天记录更新补充，非本周新发表

P 接受 axi-cel 的 R/R LBCL 患者

I 采集样本 T 细胞亚群免疫表型，尤其 CD8+CCR7+CD45RA- TCM

C 强 CAR-T 扩增者 vs 弱扩增者；CD8+ TCM >4.3% vs 较低水平

O CAR-T 扩增峰值、PFS、预处理预测能力

结论

23 例接受 axi-cel 的 R/R LBCL 患者研究显示，采集产物中较高 CD8+ central memory T cells (CCR7+CD45RA-) 与更强 CAR-T 扩增和更好 PFS 相关；>4.3% 的 CD8+ TCM cut-off 预测强扩增的 AUC 为 0.80。

主要内容

- 研究在新鲜采集样本中做 T 细胞亚群免疫表型，并用流式监测循环 CAR-T 细胞。
- 中位 peak CAR-T 计数为 45.2 CAR T-cells/mL；强扩增者定义为达到或超过该中位值。
- 强扩增者采集样本中 CD4+ 和 CD8+ TCM 更高，CD8+CD38+ T 细胞比例更低。
- 采集样本中 CD8+ TCM >4.3% 可预测强 CAR-T 扩增 (AUC 0.80) ，并与更优 PFS 相关。

关键信息

- 作者：Iván García de la Torre、Carlota García-Hoz、Fernando Martín-Moro、José Ignacio Fernández-Velasco、Kyra Velázquez-Kennedy、Eulalia Rodríguez-Martín 等。
- 研究类型：小样本转化/真实世界生物标志物研究；重点不是新疗法，而是制造前质量和动力学预测。
- 关键边界：23 例样本量有限，cut-off 需要外部验证后才能用于临床决策。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 23 例 R/R LBCL、axi-cel、采集样本流式、CD8+ TCM cut-off、AUC 0.80 和 PFS 关联。

论文作者观点

论文作者观点：采集样本中较高 CD8+ TCM 频率可能是 CAR-T 强扩增和更好临床结局的预处理标志物。

我的推断

我的推断：CAR-T 研究应把采集质量、T 细胞记忆表型、扩增峰值和 PFS 作为同一条证据链记录，避免只在输注后才解释疗效差异。

glofitamab 应答与耐药的分子特征：naive-like T 细胞状态和 4-1BB 共刺激

PMID 41569641

打开 PubMed 文献

Molecular features of response and resistance to glofitamab, a T-cell engager for treatment of large B-cell lymphoma.

双抗 / T-cell engager 耐药机制

R/R B-NHL / LBCL

MDAT 命中：近 7 天记录更新补充，非本周新发表



接受 glofitamab 的 R/R B-NHL/LBCL 患者及相关模型



纵向单细胞和功能检测：glofitamab 联合 4-1BB 共刺激的转化探索



完全代谢缓解者 vs 进展者：有无 4-1BB 共刺激



T 细胞状态、功能活性、耐药机制、模型抗肿瘤效应

结论

纵向 scRNA-seq 与功能实验显示，glofitamab 治疗后早期维持 naive-like 或 fresher cytotoxic T 细胞状态与临床疗效相关；在模型中加入 4-1BB 共刺激可增加肿瘤内 fresher T 细胞比例并增强抗肿瘤效应。

主要内容

- 研究关注 T-cell engager 疗效差异背后的免疫细胞组成和 T 细胞功能状态。
- 对 glofitamab 治疗 R/R B-NHL 后达到完全代谢缓解或进展的患者 PBMC 做纵向 scRNA-seq 和功能评估。
- 应答者 T 细胞功能活性强于非应答者，早期 fresher cytotoxic T cells 的维持与疗效相关。
- 连续 glofitamab 处理后的患者样本和模型显示 T 细胞功能可持续；glofitamab 联合 4-1BB 共刺激在模型中增强抗肿瘤效应。

关键信息

- 作者：Stephan Schmeing、Sina Nassiri、Gabrielle Leclercq-Cohen、Emilio Yángüez、Tamara Hüsser、Llucia Alberti Servera 等。
- 研究类型：患者样本纵向单细胞分析 + 功能实验 + 预临床模型；不是随机联合治疗临床试验。
- 关键边界：4-1BB 共刺激属于机制和转化假设，不能直接写成已验证临床联合方案。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 glofitamab、R/R B-NHL、纵向 scRNA-seq、PBMC/肿瘤内 T 细胞、fresher T 细胞状态和 4-1BB 共刺激模型结果。

论文作者观点

论文作者观点：fresher naive-like T 细胞状态具有治疗相关性，利用 4-1BB 共刺激可能克服 TCE 耐药并改善应答。

我的推断

我的推断：双抗研究应前置采集外周和肿瘤内 T 细胞状态、早期动态和耗竭标志，后续联合设计应优先证明免疫状态被真实重塑，而不仅比较 ORR。

PCNSL 中 tirabrutinib 相关皮肤不良事件：发生率、起病时间与处理

PMID 41621897

打开 PubMed 文献

Incidence and Management of Tirabrutinib-associated Cutaneous Adverse Events: A Case Series.

BTKi / PCNSL 安全性病例系列		PCNSL	MDAT 命中：近 7 天记录更新补充，非本周新发表				
P	接受 tirabrutinib 的 PCNSL 患者	I	tirabrutinib 治疗期间的皮肤 AE 监测与处理	C	不同皮肤 AE 类型、起病时间和处理方式的病例比较；无随机对照	O	皮肤 AE 发生率、CTCAE 分级、起病时间、处理、停药

结论

单中心 7 例 PCNSL 病例系列显示，tirabrutinib 相关皮肤不良事件较常见（5/7，71.4%），多数在 1 个月内出现且可处理，但 1 例因严重皮肤不良事件停用 tirabrutinib。

主要内容

- 纳入 2020-03-01 至 2024-02-29 接受 tirabrutinib 的 7 例 PCNSL 患者，按 CTCAE v5.0 评估皮肤事件。
- 5 例出现皮肤障碍：3 例 2 级斑丘疹、1 例 3 级多形红斑、1 例 2 级湿疹样病变。
- 中位起病 22.4 天，4 例在 1 个月内发生。
- 处理包括口服抗组胺药和外用糖皮质激素；1 例因严重事件停药。

关键信息

- 作者：Satoru Matsunuma、Harutaka Seshimo、Shigeki Sunaga、Kunitoshi Otsuka、Toru Koshiishi、Koichi Yoshimoto 等。
- 安全性记忆点：皮肤事件 71.4%，多数早发；需要把起病时间、分级、处理和停药分别记录。
- 研究边界：7 例单中心病例系列，不能稳定估计人群风险，也不能直接比较不同 BTKi。

启示

已验证证据

已验证证据：PubMed 摘要确认 PCNSL、tirabrutinib、样本量 7、皮肤 AE 类型、CTCAE 分级、起病时间、处理方式和停药病例。

论文作者观点

论文作者观点：tirabrutinib 相关皮肤不良事件常见但多数可管理，早期监测很关键，需要更大规模研究评估风险因素和预防策略。

我的推断

我的推断：PCNSL/BTKi 研究和真实世界表单应把皮肤毒性起病时间、分级、处理、停药和再挑战单独记录，尤其适用于老年 PCNSL 人群。

今天的信号不是单一药物热点，而是“疗效前移 + 治疗可及 + CNS/微环境分层 + 安全管理”同步推进

已验证证据 本轮官方候选池 202 条，筛选 5 篇未跨日重复 PMID，覆盖 DLBCL 一线治疗强度、DLBCL proteogenotype 转化分型、CAR-T 采集前生物标志物、glofitamab/T-cell engager 耐药机制和 PCNSL tirabrutinib 安全性。	论文作者观点 入选论文作者共同强调的方向是：DLBCL 结局不能只看单一疗效终点，治疗强度、分子/蛋白组分型、T 细胞状态、采集质量、CNSL 安全性窗口都应进入研究设计和随访框架。	我的推断 我的推断是，后续每日监测应继续优先选择能改变方案设计变量、分层指标、毒性管理或转化假设的研究；只提供泛泛风险预测、低相关诊断偶发或无可操作启示的条目不应为了凑数进入正文。
下一次优先跟进 继续观察 frontMIND OS/ctDNA、PCNSL 双抗 CNS 穿透验证、双抗治疗中 PET 动态指标、CAR-T 可及性和桥接前 MTV 变化。	设计启示 DLBCL/CNSL 研究应同时记录疗效、到达治疗的路径、CNS/CSF 指标、影像负荷、分子/微环境分层和感染/神经毒性安全窗口。	边界提醒 本页仅作文献监测、证据摘要和方案设计启示整理，不提供医疗建议，也不生成治疗推荐。